

1. Les pathologies des troncs supra-aortiques incluent uniquement des lésions sténosantes des vaisseaux.	1. Faux
2. L'athérome est l'étiologie principale des lésions sténosantes des vaisseaux supra-aortiques.	2. Vrai
3. Les voies anastomotiques de suppléance comprennent entre autres le polygone de Willis.	3. Vrai
4. Les lésions carotidiennes sont uniquement d'origine athéroscléreuse.	4. Faux
5. La plupart des sténoses des carotides sont asymptomatiques et découvertes par échographie-Doppler.	5. Vrai
6. Les accidents vasculaires de 20h peuvent être considérés comme des AIT.	6. Vrai
7. Les AIT sont des accidents ischémiques qui durent moins de 12h.	7. Faux
8. Les sténoses carotidiennes asymptomatiques sont parfois découvertes lors d'un bilan préopératoire de pontage coronaire.	8. Vrai
9. L'échographie-Doppler est un examen partiellement opérateur-dépendant.	9. Vrai
10. L'échographie-Doppler a une excellente sensibilité pour dépister une sténose de la carotide interne $\geq 70\%$.	10. Vrai
11. L'angiographie par résonance magnétique est l'examen de choix pour étudier les artères communicantes.	11. Faux
12. Le traitement endoluminal des sténoses carotidiennes est associé à un risque de lésion des nerfs crâniens.	12. Faux

13. L'IRM peut détecter des signes d'hémorragie intra-plaque chez les patients atteints de sténose carotidienne.	13. Vrai
14. Les lésions sténosantes des vaisseaux supra-aortiques sont principalement causées par des tumeurs.	14. Faux
15. Les voies anastomotiques de suppléance comprennent entre autres le confluent vertébrobasilaire.	15. Vrai
16. Les AIT sont des événements ischémiques transitoires qui durent moins de 24 heures.	16. Vrai
17. L'échographie-Doppler permet uniquement de visualiser la paroi vasculaire.	17. Faux
18. L'angiographie conventionnelle est l'examen de 1 ^{er} choix pour visualiser des sténoses carotidiennes.	18. Faux
19. La morbi-mortalité du traitement endoluminal des sténoses carotidiennes est supérieure à la chirurgie, surtout pour les patients jeunes et les patients asymptomatiques.	19. Faux
20. Les sténoses asymptomatiques des carotides sont souvent découvertes lors d'un bilan cardiovasculaire.	20. Vrai
21. Les lésions carotidiennes sont la cause d'environ 50% des cas d'accidents vasculaires cérébraux.	21. Faux
22. Les sténoses carotidiennes siègent principalement au niveau de la carotide primitive.	22. Faux
23. L'angiographie par résonance magnétique a tendance à surestimer la sévérité des sténoses serrées.	23. Vrai
24. Le traitement d'une sténose carotidienne asymptomatique est suggéré si l'espérance de vie est de 3 ans.	24. Faux
25. L'athérosclérose des artères vertébrales et/ou du tronc basilaire est de loin l'étiologie la plus fréquente des accidents ischémiques vertébrobasilaires.	25. Vrai

26. Un accident ischémique vertébrobasilaire peut être déclenché par une compression extrinsèque positionnelle.	26. Vrai
27. Un mécanisme hémodynamique est rarement à l'origine d'un accident ischémique vertébrobasilaire.	27. Faux
28. Les mouvements de tête peuvent diminuer le débit sanguin dans les artères vertébrales.	28. Vrai
29. Les accidents ischémiques vertébrobasilaires sont toujours causés par un mécanisme thromboembolique.	29. Faux
30. Les sténoses sous-clavières sont souvent symptomatiques.	30. Faux
31. Les sténoses sous-clavières sont souvent découvertes lors d'une prise de tension artérielle aux deux bras.	31. Vrai
32. La claudication intermittente du membre supérieur est un symptôme de sténose carotidienne.	32. Faux
33. Les sténoses du tronc artériel brachio-céphalique sont toujours asymptomatiques.	33. Faux
34. Les sténoses du tronc artériel brachio-céphalique peuvent provoquer des accidents ischémiques transitoires.	34. Vrai
35. Les dissections artérielles surviennent principalement après un traumatisme cervical.	35. Faux
36. Les dissections de la carotide interne provoquent des céphalées et des acouphènes pulsatiles.	36. Vrai
37. L'échographie-Doppler est l'examen de choix en 1 ^{ère} intention pour le diagnostic des dissections artérielles.	37. Vrai
38. L'imagerie par résonance magnétique cérébrale ne permet pas de visualiser l'hématome de paroi dans les dissections artérielles.	38. Faux
39. L'angiographie conventionnelle est toujours nécessaire pour diagnostiquer les dissections artérielles.	39. Faux

40. Les tumeurs du glomus carotidien se développent généralement dans l'intima du vaisseau.	40. Faux
41. Les paragangliomes sont généralement des tumeurs malignes qui évoluent lentement.	41. Faux
42. Les tumeurs du glomus carotidien peuvent être asymptomatiques.	42. Vrai
43. Les tumeurs du glomus carotidien se manifestent par une tuméfaction battante au niveau du cou.	43. Vrai
44. L'athérosclérose est la principale étiologie des accidents ischémiques vertébrobasilaires.	44. Vrai
45. Les dissections artérielles sont la 1 ^{ère} cause d'ischémie cérébrale chez les patients de moins de 50 ans.	45. Vrai
46. Les tumeurs du glomus carotidiens sont des tumeurs très vascularisées.	46. Vrai
47. Les paragangliomes surviennent généralement chez les personnes âgées de plus de 70 ans.	47. Faux
48. La majorité des dissections artérielles surviennent spontanément sans cause apparente.	48. Vrai
49. Les signes d'ischémie cérébrale secondaire se développent immédiatement après une dissection carotidienne.	49. Faux
50. L'échographie-Doppler n'est pas fiable pour diagnostiquer les dissections artérielles.	50. Faux
51. La radiothérapie peut induire des sténoses cicatricielles des troncs supra-aortiques.	51. Vrai
52. Les lésions sténosantes carotidiennes sont la cause d'environ 15% des AVC.	52. Vrai
53. Les lésions carotidiennes siègent surtout au niveau de la bifurcation carotidienne ou du siphon carotidien.	53. Vrai
54. Les sténoses carotidiennes n'entraînent généralement pas de souffle à l'auscultation des vaisseaux du cou.	54. Faux

55. Les ulcérations et les fragmentations de la plaque d'athérome sont à l'origine d'embolies fibrino-plaquettaires.	55. Vrai
56. Les déficits neurologiques focaux peuvent être provoqués par un épisode d'hypotension ou de bas débit cardiaque en cas de sténose peu serrée avec une suppléance vasculaire insuffisante.	56. Faux
57. L'amaurose fugace, c'est-à-dire la perte transitoire de la vision, peut être la manifestation d'un AVC.	57. Faux
58. Un AVC peut se manifester par une hémiparésie à prédominance brachio-faciale.	58. Vrai
59. Un AVC peut se manifester par une paraplégie des 2 membres inférieurs.	59. Faux
60. Les AVC et les AIT peuvent se manifester par des troubles du langage.	60. Vrai
61. L'hémi-parésie ou l'hémi-parésie sont situés du même côté que la lésion carotidienne à l'origine de l'AIT.	61. Faux
62. La perte de vision transitoire est située du même côté que la lésion carotidienne à l'origine de l'AIT.	62. Vrai
63. L'hémianopsie, l'hémi-anesthésie et la monoplégie sont des symptômes d'AVC.	63. Vrai
64. Un déficit neurologique aigu non latéralisé est compatible avec un accident ischémique.	64. Faux
65. L'épilepsie, la migraine et l'hyperglycémie font partie du diagnostic différentiel des AIT.	65. Faux
66. L'hémorragie cérébrale, les tumeurs et l'encéphalite font partie du diagnostic différentiel des AVC.	66. Vrai
67. L'AVC ischémique est causé par un embolie d'origine cardiaque dans 50% des cas.	67. Faux
68. L'AVC ischémique est causé par l'athérosclérose dans 15 à 20% des cas.	68. Vrai

69. La dissection artérielle est responsable de 20% des AVC chez les <50 ans.	69. Vrai
70. Les accidents vasculaires lacunaires correspondent l'obstruction d'un vaisseau de petit calibre.	70. Vrai
71. La dysplasie fibromusculaire est une cause rare d'AVC ischémique chez les hommes de 30-40 ans.	71. Faux
72. Les thrombophilies, la maladie de Horton et les vasculites cérébrales sont des causes rares d'AVC ischémique.	72. Vrai
73. L'écho-Doppler est l'examen de 1 ^{er} choix pour diagnostiquer les lésions carotidiennes sténosantes.	73. Vrai
74. L'écho-Doppler est un examen efficace en cas de calcifications artérielles ou chez le sujet obèse.	74. Faux
75. Une accélération du flux sanguin dans la carotide interne est le signe d'une sténose carotidienne.	75. Vrai
76. Le dépistage des sténoses carotidiennes est indiqué en cas d'AOMI ou d'anévrisme de l'aorte.	76. Vrai
77. L'écho-Doppler est réalisé après auscultation d'un souffle cervical ou après une chirurgie cardiaque pour rechercher une sténose carotidienne.	77. Faux
78. L'angiographie par résonance magnétique est l'examen de référence pour les sténoses carotidiennes.	78. Faux
79. L'angiographie conventionnelle permet une étude complète de la vascularisation par l'injection intraveineuse d'un produit de contraste iodé.	79. Faux
80. L'angiographie conventionnelle peut entraîner des complications neurologiques par embolisation des plaques athéromateuses aortiques mobilisées par le cathéter.	80. Vrai

81. Le scanner cérébral sans contraste permet de détecter une rupture de la barrière hémato-méningée.	81. Faux
82. L'angiographie par résonance magnétique ne permet pas de visualiser le polygone de Willis.	82. Faux
83. L'angiographie par résonance magnétique permet d'étudier le parenchyme cérébral.	83. Vrai
84. L'écho-Doppler a tendance à surestimer la sévérité des sténoses serrées.	84. Faux
85. Le scanner cérébral sans contraste permet de visualiser les lésions ischémiques, hémorragiques et tumorales.	85. Vrai
86. L'angio-scanner permet de mesurer précisément le pourcentage des sténoses artérielles.	86. Faux
87. Un contrôle strict des facteurs de risque et un traitement anti-agrégant plaquettaire par aspirine est nécessaire en cas de lésions sténosantes de la carotide.	87. Vrai
88. La thromboendartériectomie consiste à retirer la plaque d'athérome et l'intima par chirurgie.	88. Vrai
89. Le traitement endoluminal des sténoses carotidiennes nécessitent une anesthésie générale.	89. Faux
90. Le traitement chirurgical des sténoses carotidiennes présente des complications : AVC/AIT, infarctus du myocarde, lésions de nerfs crâniens, hématome cervical compressif,...	90. Vrai
91. Une bifurcation carotidienne haute est une contre-indication au traitement chirurgical des sténoses.	91. Vrai
92. Le traitement endoluminal des sténoses carotidiennes sera préféré en cas de récidence ou de sténose radique.	92. Vrai
93. La morbi-mortalité du traitement endoluminal des sténoses carotidiennes est inférieure à la chirurgie.	93. Faux

94. Le traitement est recommandé en cas de sténose de >50%, symptomatique (AVC/AIT dans les 6 mois précédents), avec une morbi-mortalité post-opératoire <6%.	94. Faux
95. Le morbi-mortalité post-opératoire doit être <3% pour opérer une sténose carotidienne asymptomatique.	95. Vrai
96. Une sténose asymptomatique n'est opérée qu'en présence d'éléments cliniques ou d'imagerie suggérant un risque élevé d'AVC controlatéral.	96. Faux
97. Les sténoses carotidiennes ne sont jamais opérées si elles sont <70%.	97. Vrai
98. Les sténoses carotidiennes bilatérales sont à risque plus élevé d'AVC.	98. Vrai
99. L'IRM permet de détecter les micro-emboles dans le tissu cérébral.	99. Faux
100. Les sténoses carotidiennes avec baisse de la réserve vasculaire cérébrale sont à risque moins élevé d'AVC.	100. Faux
101. L'IRM permet de détecter la rupture de la fine cape fibreuse recouvrant la plaque athéromateuse.	101. Vrai
102. L'écho-Doppler permet de détecter une plaque de surface irrégulière ou ulcérée.	102. Vrai
103. Les ostéophytes/les tassements vertébraux peuvent être responsable d'accidents ischémiques carotidiens.	103. Faux
104. La maladie de Takayasu est une cause rare d'AVC ischémique.	104. Vrai
105. Un accident ischémique vertébrobasilaire symptomatique peut survenir suite à un mécanisme hémodynamique en cas de lésion unilatérale.	105. Faux

106. L'anémie, l'IC et les mouvements de la tête peuvent favoriser les accidents ischémiques vertébrobasilaires.	106. Vrai
107. Les accidents ischémiques vertébrobasilaires thromboemboliques sont toujours causés par un embole d'origine cardiaque.	107. Faux
108. La plupart des cas d'insuffisance vertébrobasilaire sont asymptomatiques.	108. Vrai
109. Le scanner a peu d'intérêt pour détecter les lésions vertébrobasilaires.	109. Vrai
110. L'IRM permet de détecter les lésions ischémiques du tronc cérébral en cas d'insuffisance vertébrobasilaire.	110. Vrai
111. L'insuffisance vertébrobasilaire peut provoquer des troubles visuels aigus : amaurose unilatérale, diplopie, hémianopsie homolatérale homonyme,...	111. Faux
112. Le « drop-attack » est une perte soudaine de force dans les jambes entraînant une chute sans perte de connaissance typique des lésions de sténose carotidienne.	112. Faux
113. L'insuffisance vertébrobasilaire peut provoquer une surdité uni- ou bilatérale soudaine.	113. Vrai
114. L'angio-IRM est un examen efficace pour détecter les lésions vertébrobasilaires.	114. Faux
115. L'angiographie est indispensable au bilan préopératoire des lésions vertébrobasilaires.	115. Vrai
116. La plupart des cas de sténoses vertébrobasilaires bénéficient d'un traitement chirurgical.	116. Faux
117. Les lésions des troncs supra-aortiques sont souvent situés à l'origine des artères sur la crosse aortique.	117. Vrai

118. Les lésions carotidiennes sont toujours traitées avant les lésions vertébrobasilaires pour essayer d'améliorer les symptômes.	118. Vrai
119. L'artère sous-clavière droite est la plus fréquemment touchée par les lésions des troncs supra-aortiques.	119. Faux
120. Le tronc artériel brachio-céphalique est plus fréquemment touché que les carotides primitives.	120. Vrai
121. Une asymétrie de pulsatilité ou de PA doit faire suspecter une lésions des troncs supra-aortiques.	121. Vrai
122. Les lésions sous-clavières peuvent provoquer des lésions ischémiques distales d'origine embolique.	122. Vrai
123. Le vol vertébral se produit en cas de sténose de la carotide en amont de l'origine de l'artère vertébrale.	123. Faux
124. Les sténoses sous-clavières sont le plus souvent très symptomatiques avec une claudication intermittente du membre supérieur et des nécroses digitales.	124. Faux
125. Le syndrome de vol sous-clavier est le plus souvent bien toléré.	125. Vrai
126. Le vol sous-clavier se manifeste par des symptômes d'insuffisance vertébrobasilaire provoqués par l'utilisation du bras.	126. Vrai
127. Le syndrome de vol sous-clavier est caractérisée par une inversion du flux dans l'artère vertébrale.	127. Vrai
128. Les sténoses des troncs supra-aortiques n'entraînent jamais de souffles artériels.	128. Faux
129. Les examens complémentaires sont indiqués uniquement pour la sténose sous-clavière symptomatique.	129. Vrai

130. Les sténoses asymptomatiques des sous-clavières ne nécessitent pas de traitement	130. Vrai
131. L'écho-Doppler permet d'objectiver le sens du flux sanguin en cas de vol vertébral.	131. Vrai
132. Les lésions du tronc brachio-céphalique entraîne une insuffisance artérielle du membre supérieur gauche.	132. Faux
133. Le traitement endoluminal est le traitement de choix pour les sténoses sous-clavières asymptomatiques.	133. Faux
134. Des greffes veineuses carotido-sous-clavières sont utilisées pour traiter les sténoses sous-clavières.	134. Vrai
135. Les lésions du tronc brachio-céphalique peuvent provoquer des AVC dans le territoire vertébrobasilaire.	135. Vrai
136. Les lésions du tronc brachio-céphalique peuvent provoquer des AVC dans le territoire carotidien.	136. Vrai
137. Le traitement endovasculaire des lésions du tronc artériel brachio-céphalique présente des risques d'embolies cérébraux.	137. Vrai
138. Les dissections artérielles surviennent rarement spontanément.	138. Faux
139. La dissection de la carotide interne entraîne des AIT/AVC dans le territoire de la cérébrale antérieure.	139. Faux
140. La déchirure de la paroi artérielle survient toujours entre la média et l'intima.	140. Faux
141. Les dissections artérielles sont favorisées par la dysplasie fibromusculaire et le syndrome de Marfan.	141. Vrai
142. L'hématome sous-intimal provoque une augmentation du diamètre de l'artère disséquée.	142. Faux
143. La dissection artérielle peut évoluer vers un pseudo-anévrisme.	143. Vrai

144. L'hématome sous-adventitial peut entraîner une sténose de l'artère disséquée.	144. Faux
145. L'ischémie cérébrale secondaire survient quelques heures à 1 mois après une dissection carotidienne.	145. Vrai
146. La dissection artérielle peut entraîner des douleurs par compression des structures avoisinantes.	146. Vrai
147. La dissection de l'artère vertébrale peut provoquer une atteinte des nerfs crâniens.	147. Faux
148. La dissection intracrânienne de l'artère vertébrale peut provoquer une hémorragie méningée.	148. Vrai
149. L'angiographie par résonance magnétique ne permet pas de visualiser une artère disséquée.	149. Vrai
150. L'écho-Doppler montre une occlusion "en flamme de bougie" en cas de dissection artérielle.	150. Faux
151. L'angiographie conventionnelle montre une sténose longue et irrégulière en cas de dissection artérielle.	151. Vrai
152. L'angiographie conventionnelle permet de diagnostiquer une dysplasie fibro-musculaire.	152. Vrai
153. L'écho-Doppler est l'examen de référence en cas de dissection artérielle.	153. Faux
154. L'écho-Doppler permet de voir un décollement intimal, une double lumière et un hématome de paroi en cas de dissection artérielle.	154. Vrai
155. Un traitement antiplaquettaire est suffisant en cas de dissection artérielle sans signes d'ischémie cérébrale.	155. Vrai
156. L'AVC secondaire à une dissection artérielle doit être traité par thrombolytique ou thrombectomie.	156. Vrai
157. Les tumeurs du glomus carotidien touche préférentiellement les femmes entre 40 et 60 ans.	157. Faux

158. Les symptômes des tumeurs du glomus carotidien sont liés à une compression locale ou à l'atteinte d'un nerf : douleurs cervicales ou dans l'oreille, raucité de la voix, dysphagie,...	158. Vrai
159. L'imagerie permet de détecter les tumeurs du glomus carotidien comme des lésions hypoperfusées.	159. Faux
160. Les tumeurs du glomus carotidien sont traités par exérèse chirurgicale.	160. Vrai
161. L'angio-IRM, l'écho-Doppler ou l'artériographie détecte un « blush tumoral » en cas de paragangliome.	161. Vrai
162. La morbi-mortalité doit être inférieure à 6% pour opérer une sténose carotidienne asymptomatique.	162. Faux
163. Les sténoses carotidiennes doivent être supérieures à 80% pour être opérées.	163. Faux
164. L'espérance de vie du patient doit être >5 ans pour opérer une sténose carotidienne asymptomatique.	164. Vrai
165. La morbi-mortalité doit être inférieure à 3% pour opérer une sténose carotidienne symptomatique.	165. Faux